

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
02/10/2023	02/10/2025	nº 06	SES.ENF nº 08	01 à 08
Nome do Procedimento: Cateterismo Vesical de Demora				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária.				
Serviço: Unidade Básica de Saúde da Família, Serviços Especiais e Pronto Atendimento				
Executantes: Enfermeiros				
Objetivo: Orientar a padronização do procedimento de Cateterismo Vesical de Demora				
Recursos necessários: ✓ Prescrição médica; ✓ Luva estéril; ✓ Luva de procedimento; ✓ Bandeja de cateterismo vesical esterilizada: cuba rim, pinça, cuba redonda, gazes e campo; ✓ Mesa auxiliar; ✓ Sonda de foley; ✓ Bolsa coletora de urina estéril; ✓ Água destilada; ✓ Agulha para aspiração; ✓ 02 Seringas de 20ml slip (sem rosca); ✓ Cloridrato de lidocaína 2% - gel; ✓ Fita adesiva (esparadrapo ou adesivo hipoalergênico); ✓ Gaze estéril; ✓ Clorexidina aquosa 2%; ✓ Água; ✓ Sabão; ✓ Papel toalha e/ou compressa; ✓ Biombo; ✓ Saco para lixo.				

Conceito

O cateterismo vesical de demora é um procedimento estéril que consiste na introdução de uma sonda da uretra até a bexiga, permanecendo por mais tempo para drenagem contínua, utilizando um cateter de *Foley* ou de *Owen*.

Indicação

- ✓ Alívio da retenção urinária aguda ou crônica como aquela decorrente de obstrução uretral ou prostática (uropatia obstrutiva) ou bexiga neurogênica;
- ✓ Tratamento da incontinência severa, neurogênica ou pós cirúrgicos;
- ✓ Monitoramento do débito urinário;
- ✓ Irrigação da bexiga ou instilação de medicação.

Contraindicações relativas

- ✓ História de estenose uretral;



- ✓ Infecção do trato urinário (ITU) atual;
- ✓ Reconstrução uretral prévia;
- ✓ Suspeita de lesão uretral (em situações de trauma ou lesão corto contuso com sinais de sangue no meato uretral, incapacidade aguda de urinar ou equimose e/ou edema perineal, escrotal ou peniana, deve-se descartar ruptura da uretra;
- ✓ Cirurgia urológica recente;
- ✓ Histórico de resistência na passagem de sonda vesical.

Complicações

- ✓ Lesão na uretra, próstata ou bexiga com sangramento;
- ✓ Infecção do trato urinário;
- ✓ Criação de falsos trajetos;
- ✓ Cicatrizes e estenoses uretrais;
- ✓ Parafimose.

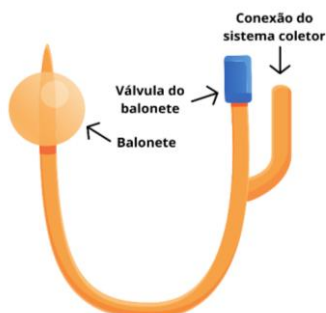
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Pré-inserção

- ✓ Revisar os registros do usuário, buscando a indicação do procedimento e a prescrição médica;
- ✓ Avaliar as condições do usuário: mobilidade, limitações físicas, nível de consciência, capacidade de compreensão e cooperação, padrão e última eliminação urinária, alterações geniturinárias, intercorrências ou alergias;
- ✓ Realizar prescrição de enfermagem de uma unidade de cloridrato de lidocaína 2% - gel em nome do usuário em prontuário eletrônico para retirada na farmácia da unidade;
- ✓ Reunir todo o material necessário;
- ✓ Organizar o material sobre uma bancada, mesa auxiliar ou superfície de apoio;
- ✓ Explicar o procedimento e a finalidade ao usuário e/ou acompanhante;
- ✓ Promover ambiente iluminado e privativo, podendo ser utilizado o biombo;
- ✓ Higienizar as mãos conforme procedimento operacional padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Calçar a luva de procedimento;
- ✓ Posicionar o usuário em decúbito dorsal. Nos casos de usuária, posicioná-la em decúbito dorsal na posição de litotomia: pernas flexionadas, afastadas e calcanhares apoiados no leito;
- ✓ Realizar higiene com água e sabão na região perineal e do genital;
- ✓ Utilizar compressa ou pano limpo para secagem das regiões higienizadas;
- ✓ Higienizar as mãos conforme procedimento operacional padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Abrir a bandeja de cateterismo vesical esterilizada;
- ✓ Adicionar gaze dentro da bandeja de cateterismo vesical se necessário;
- ✓ Abrir e colocar na bandeja de cateterismo vesical esterilizada os materiais: bolsa coletora de urina estéril, sonda de *foley* de acordo com a indicação e característica do usuário, 02 seringas de 20 ml com bico *slip* e agulha para aspirar a água destilada;
- ✓ Inserir a Clorexidina aquosa a 2% dentro da cuba redonda;
- ✓ Acrescentar o cloridrato de lidocaína 2% gel na cuba rim no cateterismo vesical feminino. Nos casos de cateterismo vesical masculino, colocar o cloridrato de lidocaína 2% gel na cuba rim e posteriormente aspirar o gel com a seringa de 20 ml (caso não tenha um profissional para auxiliar);
- ✓ Realizar a assepsia da ampola da água destilada, abrir o lacre e posicionar a ampola de modo que seja possível aspirar o conteúdo de forma fácil;
- ✓ Higienizar as mãos conforme procedimento operacional padrão (POP - Rotina nº 23);
- ✓ Calçar as luvas estéreis;
- ✓ Conectar a agulha na seringa *slip* e aspirar a água destilada na quantidade indicada pelo

- ✓ fabricante, descrito no conector da sonda de *foley*;
- ✓ Desconectar a agulha, e conectar a seringa na válvula do balonete para testar a integridade insuflando a água aspirada;

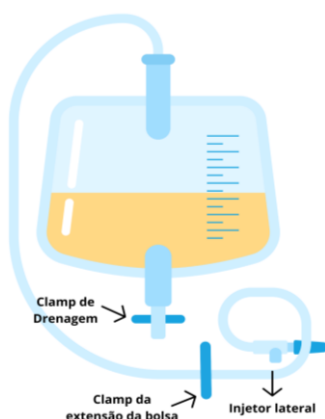
Figura 01 – Descritivo técnico da sonda *foley*



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial, 2023

- ✓ Desinsuflar o balonete aspirando totalmente o conteúdo injetado;
- ✓ Conectar a sonda de *foley* na bolsa coletora de urina estéril, e não desconectá-las para manter o sistema fechado;
- ✓ Manter aberto o *clamp* da extensão da bolsa de drenagem e fechar o *clamp* de drenagem;

Figura 02 – Descritivo técnico da bolsa coletora



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial, 2023

Sexo Feminino

- ✓ Realizar antisepsia da genitália, no sentido anteroposterior e lateral-medial com torundas de gaze embebidas com clorexidina aquosa 2%;
- ✓ Abrir suavemente os grandes e pequenos lábios e expor o meato uretral, usando a mão não dominante;

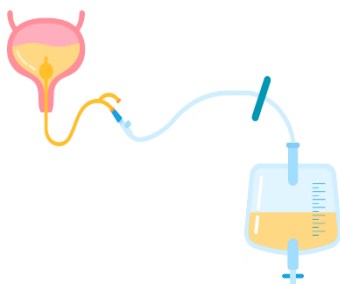
Figura 03 – Descritivo técnico antisepsia – feminina



Fonte: Potter, 2018

- ✓ Realizar a antisepsia ao redor do meato uretral com movimento circular;
- ✓ Colocar o campo fenestrado estéril sobre a pelve de modo que a vulva permaneça exposta.
- ✓ Segurar e enrolar frouxamente a sonda na palma da mão;
- ✓ Lubrificar a sonda de *foley* com lidocaína gel 2%;
- ✓ Introduzir lentamente a sonda de *foley* no meato uretral até o retorno da urina espontaneamente na bolsa coletora de urina estéril. Introduzir a sonda de *foley* mais cinco centímetros;
- ✓ Inflar o balonete com a água destilada;
- ✓ Tracionar a sonda delicadamente até obter resistência;

Figura 04 – Descritivo técnico do cateterismo vesical de demora



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial, 2023

- ✓ Fixar a sonda de *foley* com a fita adesiva no nível da bifurcação da ponta da sonda, na região da face interna da coxa, permitindo livre movimentação da perna e evitando tração da sonda;

Sexo Masculino

- ✓ Segurar o pênis com a mão não dominante e retraindo o prepúcio;
- ✓ Realizar antisepsia da genitália com torundas de gaze embebidas com clorexidina aquosa 2%, com movimentos circulares ou perpendiculares, no sentido do prepúcio para a base do pênis;
- ✓ Realizar a antisepsia do meato uretral;
- ✓ Colocar o campo fenestrado estéril sobre a pelve de modo que o pênis permaneça exposto;
- ✓ Posicionar o pênis à 90° em relação ao corpo do paciente com a mão não dominante;
- ✓ Introduzir lidocaína gel 2% com a seringa lentamente no meato urinário com a mão dominante e comprimir o meato (com a mão não dominante) a fim de manter o Cloridrato de lidocaína 2% - gel dentro da uretra até a introdução da sonda;
- ✓ Introduzir com a sonda com a mão dominante até a bifurcação no meato uretral, e observar presença de urina na extensão da bolsa coletora de urina estéril;

Figura 05 – Descritivo técnico da passagem de sonda vesical – masculino



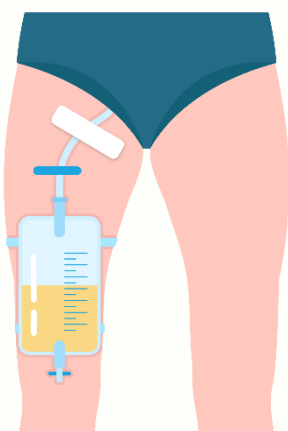
Fonte: Potter, 2018

- ✓ Inflar o balonete com a água destilada;
- ✓ Tracionar lentamente a sonda de foley até apresentar resistência;
- ✓ Reduzir o prepúcio após o procedimento;
- ✓ Posicionar o pênis sobre a região suprapúbica, mantendo-o voltado para cima, fixando com a fita adesiva a sonda de foley sem tracioná-la.

Pós procedimento

- ✓ Posicionar a bolsa coletora de urina estéril do mesmo lado em que foi fixado a sonda de foley e abaixo do nível da bexiga;

Figura 06 – Posicionamento da bolsa coletora



Fonte: Núcleo de Gestão Assistencial, 2023

- ✓ Aguardar a drenagem da urina, observar o volume total drenado e as características da urina;
- ✓ Auxiliar o usuário a se vestir e/ou coloque a fralda descartável;
- ✓ Recolher o material utilizado, e descartar conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 38);
- ✓ Retirar as luvas;
- ✓ Identificar a bolsa coletora de urina estéril com data, número da sonda, volume injetado no balonete, nome do profissional;
- ✓ Higienizar as mãos conforme procedimento operacional padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Orientar usuário sobre os devidos cuidados com a sonda e período para troca, se necessário;
- ✓ Registrar o procedimento em prontuário eletrônico;

Troca e retirada da sonda vesical de demora

Não há um consenso técnico quanto ao intervalo fixo de troca, porém, indica-se a média para substituição de 21 dias;

Deve ser realizada a troca do sistema quando houver:

- ✓ Incrustações, resíduos, depósitos ou sujeira no trajeto da sonda e bolsa coletora de urina estéril;
- ✓ Sinais de infecção urinária (púls, grumos, odor fétido, dor no trajeto da sonda, dor em região suprapúbica, dor lombar recorrente, febre);
- ✓ Perfurações, rasgos, vazamentos ou danos ao sistema;
- ✓ Desconexão acidental do sistema;
- ✓ Obstrução de qualquer parte do sistema.

OBSERVAÇÕES

- ✓ O meato uretral feminino das idosas pode estar retraído em direção a entrada da vagina, devendo o profissional realizar inspeção prévia e tracionamento manual;
- ✓ A uretra masculina se curva contra o púbis, portanto, ao passar a sonda de *foley*, manter o pênis na posição vertical para reduzir a obstrução da curva;
- ✓ A drenagem da urina no cateterismo vesical masculino pode iniciar antes da sonda de *foley* estar propriamente na bexiga;
- ✓ Interromper o procedimento nas seguintes situações:
 - Resistência significativa;
 - Considerar que a sonda está curvando-se na uretra;
 - Apresentar desconforto e/ou dor intensa;
 - Observar sangramento abundante;
 - Não houver drenagem da urina mesmo após confirmação do posicionamento e relato de sensação de bexiga cheia pelo usuário;
- ✓ A sonda de *foley* deve ser obrigatoriamente trocada toda vez que for manipulado inadequadamente;
- ✓ Deve-se descartar a sonda de *foley* nas situações de introdução acidental na vagina;
- ✓ A bisnaga de cloridrato de lidocaína 2% gel ao final do procedimento deve ser desprezada para evitar contaminação cruzada;
- ✓ O cloridrato de lidocaína 2% gel pode obstruir drenagem da urina quando o gel entra nos orifícios de drenagem. Realize uma pressão com os dedos na bifurcação da sonda, de modo a promover uma leve ordenha no trajeto, ou realize uma lavagem do sistema, em torno de 20 ml de água destilada ou soro fisiológico 0,9% via injetor lateral da bolsa coletora de urina estéril;
- ✓ Em caso de incapacidade de finalizar o procedimento, o paciente deve ser encaminhado para serviço de referência em urologia ou cirurgia geral, para avaliação;
- ✓ Após retirada definitiva da sonda, recomenda-se observar a eliminação espontânea da urina e anotar o horário, o volume e o aspecto da primeira micção espontânea;
- ✓ Deve-se avaliar nova sondagem vesical de demora ou alívio nos casos de globo vesical ou dor intensa após retirada da sonda, conforme prescrição médica;
- ✓ Usuários de sonda vesical de demora residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), devem ter o cuidado compartilhado com a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de referência. O procedimento pode ser realizado pela equipe de enfermagem do ILPI, porém, não isenta o acompanhamento, registros dos dispositivos e controle de infecção pela equipe da UBSF. O acompanhamento e manejo do idoso é de responsabilidade da equipe da UBSF, e a equipe do ILPI deve participar ativamente do cuidado;
- ✓ Nos casos de sondagem domiciliar, os materiais podem ser descartados na residência do usuário. A equipe deve apenas remover os perfurocortantes.

Orientação ao Usuário e/ou ao Cuidador referente ao manuseio em Domicílio

- ✓ Higienizar as mãos com água e sabão antes e depois de manusear a sonda;
- ✓ Realizar higiene com água e sabão neutro diariamente do meato uretral, trajeto da sonda e conexão com a bolsa coletora;
- ✓ Realizar higiene íntima após eliminações intestinais com água e sabão neutro (usuário acamado e do sexo feminino);
- ✓ Fixar a bolsa coletora de urina estéril na lateral da cama, cadeira de rodas ou perna, sempre abaixo do nível da cama ou do assento da cadeira. Não deve encostar no chão;
- ✓ Clampear a extensão da sonda de foley durante a movimentação do usuário (deitar/levantar/mudar o decúbito);
- ✓ Fixar a sonda de foley de forma que não a tracione;
- ✓ Desprezar a diurese quando atingir no máximo $\frac{2}{3}$ da capacidade da bolsa coletora de urina estéril.

REFERÊNCIAS

1. CHUNG, Paul H.; Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University. **Como fazer cateterismo uretral em um homem** - Distúrbios geniturinários. Manuais MSD edição para profissionais. 2020;
2. UFRSG. Serviço de Enfermagem em Saúde Pública. Manual de Orientações – **Cateterismo Vesical Intermitente**. Educação em Saúde, Vol 35. Hospital de Clínicas, Porto Alegre. 2018;
3. COREN Santa Catarina. PARECER COREN/SC Nº 001/CT/2017 Assunto: **Cateterismo vesical de alívio (CVA) por pacientes ou familiares nas dependências de unidades hospitalares**. Disponível em:
file:///M:/SAUDE/GAB/NARAS/POP%20para%20revis%C3%A3o/Cateterismo%20vesical/Parecer-T%C3%A9cnico-001-2017-Cateterismo-Vesical-CT-M%C3%A9dia-e-Alta-Complexidade-2.pdf;
4. CHUNG, Paul H.; Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University. **Como fazer cateterismo uretral em uma mulher** - Distúrbios geniturinários. Manuais MSD edição para profissionais. 2020;
5. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde**. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília: Anvisa, 2017. Disponível em:
<http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/medidas-de-prevencao-deinfeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude-;>
6. CARMAGNANI, Maria I., FAKIH, Trevisani, CANTERAS, Lígia Mara Silva, TERERAN, N. **Procedimentos de Enfermagem** - Guia Prático, 2ª edição. Guanabara Koogan, 04/2017;
7. OLIVEIRA, R. G. **de Blackbook – Enfermagem**. Belo Horizonte: Blackbook Editora, 2016;
8. POTTER, P. A.; PERRY, A.G.; STOCKERT, P.; HALL, A. **Fundamentos de Enfermagem**. 9ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018;
9. BEZERRA, Carlos A. et. al. **Cateterismo Vesical Intermitente**: Indicações e Técnica. Portal da Urologia. 2015.

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI): 23.0.209571-0

Wiki da Prefeitura – <https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:Saúde>

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Fernanda Cristina Spiller	Gabriela Cristina da Silva Brandão Manuelle Hölscher Belz	Maristela Mello de Aguiar Vanessa Cardoso Pacheco



Alteração após Revisão			
Versão	Data	Responsável	Alteração
06	Jul/2023	Fernanda Cristina Spiller Manuelle Hölscher Belz	✓ Modificação do texto; ✓ Inclusão de informações específicas para coleta de amostra; ✓ Reorganização do texto; ✓ Atualização de conteúdo geral.

